Sujet n°1 : Traumatisme cranien

Spécialité : Anesthésie-réanimation

Date : 17/01
Auteur : Marion BUISSET (DESAR 1 Lyon)
Relecteur(s) : Alexis PROVENCHERE (DASAR 1 Toulouse) et Lucie Lou VIAL (DESAR 2 Toulouse)

Domaine d'apprentissage principal	stratégie pertinente de prise en charge
Domaine d'apprentissage secondaire	iconographie
Item(s) en lien avec la station	Prise en charge immédiate pré-hospitalière et à l'arrivée à l'hôpital, évaluation des complications chez : un brûlé, un polytraumatisé, un traumatisé thoracique, un traumatisé abdominal, un traumatisé des membres et/ou du bassin, un traumatisé du rachis ou vertébro-médullaire, un traumatisé crânien ou crânio-encéphalique
Situation(s) de départ en lien avec la station	Traumatisme cranien ; Traumatisme sévère
Matériel nécessaire à la station	scanner cérébral à donner à l'étudiant lorsque demande boddy scanner/fin de tache 1
Contexte de la station	

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes interne d'anesthésie réanimation au déchocage de votre CHU et vous allez évaluer Mme P, une patiente de 25 ans qui, en traversant au passage piéton s'est fait renverser par une voiture roulant à 70 km/h.
Les constatations cliniques du SAMU sont les suivantes :

- TA 108/68 mmHg, FC 110 bpm, saturation en aa 92%, T° 37°C, Glycémie capillaire 2,3 g/L
- GSC 14 (M6, V4, Y4), pas de déficit sensitivo-moteur, pupilles intermédiaires, réactives, symétriques, paires crâniennes intègres
- FR 25/minute, MV aboli en base G avec matité à la percussion
- Pas d'hémorragie extériorisée, membre inférieur gauche déformé sans plaie cutanée, sans troubles sensitivo-moteur ni vasculaire
- A 25 minutes du traumatisme, céphalées puis dégradation neurologique brutale GSC 5 (M2, V2, Y1), anisocorie avec mydriase G. TA à 93/57 mmHg

La prise en charge a consisté en un respect de l'axe tête-cou-tronc, la pose de 2 VVP, une intubation oro-trachéale après la dégradation neurologique avec sédation par sufentanyl et midazolam, curarisation par rocuronium.

La patiente est actuellement stabilisée. En intra-hospitalier, la radiographie du bassin ne montre pas de fracture, la radiographie thoracique couchée montre une opacité du poumon G.

Consignes :

Vous devez en 8 minutes :

- Donner les 2 examens complémentaires d'imagerie à réaliser chez cette patiente.
- Décrire l'examen demandé qui vous sera fourni
- Donner la prise en charge initiale de cette patiente en fonction de vos conclusions radiologiques

Vous ne devez pas :

- Réaliser d'ordonnance
- Demander des examens complémentaires non radiologiques
- Énoncer une prise en charge sur d'autres aspects que les conclusions radiologiques

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques (max 15 items)			
Tache 1			
1.	Dit « fast échographie » ou « fast écho »	*1 pt*	☐
2.	Dit « body scanner » ou « scanner corps entier », compter le point si précise ou non une injection de produit de contraste	*1 pt*	☐
Tache 2			
3.	Dit scanner cérébral sans injection de produit de contraste	1pt	☐
4.	Dit coupe axiale ou coupe transversale	1 pt	☐
5.	Dit hyperdensité en lentille biconvexe	*1 pt*	☐
6.	Dit déviation de la ligne médiane à droite ou effet de masse vers la droite ou engagement sous falcoriel gauche	*1 pt*	☐
7.	Dit hématome extra dural gauche	*1 pt*	☐
Tache 3			
8.	Énonce une injection de mannitol ou de sérum salé hypertonique ou osmothérapie	*1 pt*	☐
9.	Énonce contrôle de la tension artérielle ou normalisation de la tension artérielle	*1 pt*	☐
10.	Énonce correction d'une hyperglycémie	*1 pt*	☐
11.	Énonce maintien d'une normo SpO2 et/ou d'une normocapnie	*1 pt*	☐
12.	Énonce éviter une hyperthermie ou corriger une fièvre ou maintien d'une normothermie	*1 pt*	☐
13.	Énonce maintien d'une normonatrémie ou respect de l'osmolarité plasmatique	*1 pt*	☐
14.	Énonce une surveillance/réévaluation de l'état de conscience/du score de Glasgow	*1 pt*	☐
15.	Énonce une demande d'avis neurochirurgical	*1 pt*	☐
Communications et attitudes (ICI) (max 5 grilles)			
1.	**8. APTITUDE À FAIRE LA SYNTHÈSE DES DONNÉES**		

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
N'arrive pas à faire ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème quelquefois sans les justifier	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Fait ressortir les éléments positifs et négatifs pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Agit avec assurance et sans erreur

2.	**12. APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE (situations aiguës / chroniques)**				
	Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
	Est incapable de proposer une prise charge adaptée à la situation clinique	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels, n'arrive pas à justifier la démarche	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels et justifie la démarche.	Propose une prise pertinente. Ne s'attarde pas au traitement/prise en charge inutile et justifie la démarche.	Etablit l'ordre de priorité des différents aspects de la prise en charge du patient (hiérarchise).
TOTAL (max 20 items)					**X points**

Éléments de rétroaction :

- Identifier un polytraumatisé
- Bien connaître les examens d'imageries complémentaires à réaliser chez le polytraumtisé
- Connaître la présentation radiologique d'un hématome extra dural et la sémiologie scannographique
- Connaître tous les ACSOS
- Ne pas oublier l'avis neurochirurgical lors d'un traumatisme cranien avec lésions radiologiques

NE PAS OUBLIER DE METTRE LE DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE SUR LE DRIVE

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR (FACULTATIF)

Plan de la station ECOS :

Donner le scanner cérébral lorsque l'étudiant a fini la tache 1. Le donner même si l'étudiant ne demande pas de boddy scanner.

Documents présents dans la station :

- *Scanner cérébral, non visible initialement par le candidat*